TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
8ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

SENTENÇA

Processo nº:	**1112876-32.2024.8.26.0100**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos**
Requerente:	**Valeria Aparecida Banepe**
Requerido:	**Notre Dame Intermédica Saúde S.A**

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos Eduardo Vieira Ramos**

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de ação proposta por VALERIA APARECIDA BENEPE em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que "*é cliente da Requerida, no plano "726 SMART 200 SP OESTE", Carteirinha "1398.0512.0000.0001.201.0133", em plano coletivo empresarial, com cobertura "AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA", em acomodação de enfermaria, conforme anexa carteirinha*"; que após "*a realização de exames pertinentes realizados em 2024, (doc. 02), a Autora recebeu o diagnóstico de ser portadora de neoplasia maligna de pulmão (CID 10: C340), diagnóstico constatado após a biópsia tecidual" e "diante do diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, a recomendação da Dra. Coski para iniciar o tratamento com o protocolo Carboplatina AUC5 + Permetrexed 500mg/ml + Pembrolizumabe 200mg endovenoso a cada 21 dias*".

Requer-se a procedência dos pedidos, no sentido de que a "*parte Requerida seja compelida a autorizar imediatamente − e sob pena de multa diária de R$.50.000,00 − valor elevado diante das notícias de reiterados descumprimentos e sem prejuízo de majoração em caso de resistência ao cumprimento (docs. 11 a 15) − O TRATAMENTO PRESCRITO À AUTORA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO QUIMIOTERÁPICO PEMBROLIZUMABE / KEYTRUDA (DOC. 03), DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA (DOC. 07) COM AMPARO EM LITERATURA MÉDICA (DOCS. 04 E 05) E PARECERES NATJUS FAVORÁVEIS (DOC. 06), revertendo-se as negativas da Ré (docs. 08 e 09), destacando-se a prescrição (doc. 03)*" (fls. 1/24).

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (fls. 296/301).

Em contestação, a parte requerida sustenta a improcedência dos pedidos (fls. 352/368).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

Réplica (fls. 410/429).

Em especificação de provas (fls. 451/452), a parte requerida pleiteou a realização de prova pericial.

Ausentes outras provas a serem produzidas, os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARES

Julgamento antecipado do mérito

Em especificação de provas, a parte requereu a realização de prova pericial.

Não há razão para que os pedidos probatórios sejam acolhidos.

De início registre-se que "*para fixar o tema da prova, o juiz empreenderá minucioso e atento exame do processado, definindo os pontos de fato convergentes e os divergentes*" e "*o resultado do cotejo implicará a emissão de juízo de pertinência entre o tema e o meio da prova, operações logicamente distribuídas no art. 357, II*" (ASSIS, A., Processo Civil Brasileiro - Parte Especial: Procedimento Comum (da demanda à coisa julgada), 1.ª Ed., Revista dos Tribunais), sendo que é ônus de quem requer a prova estabelecer nexo de pertinência concreta entre o ato instrutório e a controvérsia trazida a juízo, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP, AC n.º 1000141-41.2021.8.26.0430, Rel. Alexandre Coelho, 8.ª Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2022; TJSP, AC n.º 1067039-90.2020.8.26.0100, Rel. Luís Roberto Reuter Torro, 27.ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/05/2022).

Com efeito, no caso dos autos, a parte não de desincumbiu do ônus de estabelecer relações lógicas de pertinência e de necessidade concreta entre a providência probatória pleiteada, o ponto controvertido e a tese que objetiva demonstrar em juízo, cabendo referir, ademais, que "*é ao juiz, como destinatário das provas, que incumbe aquilatar a necessidade e pertinência das provas especificadas, voltadas à formação de seu convencimento*" (TJSP, AC n.º 1105460-96.2013.8.26.0100, Rel. Claudio Godoy, 1.ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/04/2024).

Isso porque, quanto ao pedido de prova pericial, ele não se mostra necessário.

Com efeito, a controvérsia que, segundo sustenta a parte requerida, seria objeto da prova pericial, seria o fato de que "*o tratamento prescrito pelo médico assistente não está em consonância com a recomendação da ANS e a melhor literatura médica, além de colocar a vida da autora em risco, ao ser submetida a um tratamento não reconhecido pela comunidade*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

científica" (fl. 452).

O tratamento em questão, como se depreende da inicial, diz respeito ao "*protocolo Carboplatina AUC5 + Permetrexed 500mg/ml + Pembrolizumabe 200mg endovenoso a cada 21 dias*", em razão de diagnóstico de "*neoplasia maligna de pulmão (CID 10: C340)*" (fl. 2).

A prova pericial, entretanto, não se faz necessária.

Com efeito, tem-se dos documentos acostados na inicial vasto acervo probatório no sentido de que, em primeiro lugar, a parte autora de fato é portadora da patologia, o que se vê do resultado dos exames de fls. 27/31, bem como, em segundo, que a médica que acompanha a parte, a oncologista Dra. Vivian C. Santos Coski prescreveu o tratamento como adequado à abordagem da patologia, fazendo-o de forma fundamentada no aumento da sobrevida do paciente (fl. 32):

Relatório Médico ao Convênio

Indico tratamento com quimioimunoterapia neoadjuvante para tratamento de adenocarcinoma de pulmão estadiamento IIIA.

Indico protocolo do estudo Keynote 671 que mostrou AUMENTO DA SOBREVIDA LIVRE DE EVENTOS DE 62,4% no grupo que recebeu PEMBROLIZUMABE neoadjuvante versus 40.6% no grupo placebo; houve também AUMENTO DA SOBREVIDA GLOBAL DE 80.9% VERSUS 77.6%, e RESPOSTA PATOLÓGICA MAIOR EM 30.2% VERSUS 11% no grupo placebo.

Além dos dados do estudo de fase 3 Keynote 671, há a indicação formal do protocolo no bulário da Anvisa: "KEYTRUDA® em combinação com quimioterapia a base de platina é indicado para o tratamento neoadjuvante de pacientes com CPCNP ressecável em estádio II, IIIA ou IIIB (T3-4N2), e então continuado como monoterapia para tratamento adjuvante.*

Nesse particular, para além de tal fato, depreende-se de notas técnicas produzidas pelo NAT-JUS em casos semelhantes, a exemplo da NOTA TÉCNICA Nº 78/2023 - NAT-JUS/SP, em caso de "*Adenocarcinoma de pulmão − CID C34.9*", no qual se concluiu que "*o pembrolizumabe é um anticorpo monoclonal utilizado em diversos tipos de neoplasias. Uma delas é a neoplasia de pulmão não-pequenas células com expressão de PDL-1. O benefício de sobrevida global foi encontrado independentemente do nível de expressão de PD-L1 quando comparado a quimioterapia convencional baseada em platina*", com posicionamento favorável ao fornecimento do fármaco.

No mais, em casos semelhantes, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem se posicionado pelo deferimento do fármaco para o tratamento da patologia ora sob análise:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA − Ação de Obrigação de Fazer − Saúde − Medicamento − PEMBROLIZUMABE − Portador de "Câncer de Pulmão Metastático e Sistema Nervoso Central" − Necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde − Manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado. Competência solidária dos entes federados − Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça. Pretensão da Fazenda do Estado de inclusão da União na lide e remessa dos autos à Justiça Federal − Desnecessidade − Temas 793 e 1.234 do STF. Aplicação à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ − Tema n.º 106 de Recurso Repetitivo/STJ. Medicamento que se encontra incorporado no Sistema Único de Saúde − SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 23, de 04 de agosto de 2020. Preliminares rejeitadas − Sentença mantida − Recursos desprovidos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004492-82.2024.8.26.0032; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2024; Data de Registro: 19/09/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Obrigatoriedade de fornecimento de medicamento Pembrolizumabe para tratamento de câncer de pulmão. Sentença procedência. Irresignação da ré. Sustenta a legalidade da negativa uma vez que há previsão contratual e amparo na Resolução Normativa 465 da ANS. Descabimento. Súmula 102 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e precendentes Jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. Taxatividade do rol da ANS em regra, havendo hipóteses excepcionais. Entendimento do C. STJ. Recurso Improvido. Apelação do autor. Impugnação ao valor da causa. Atribuição de acordo com o proveito econômico aferível. Acolhimento. Precedentes jurisprudenciais. Recurso Provido. Sentença reformada em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1139050-15.2023.8.26.0100; Relator (a): Rui Porto Dias; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau − Turma V (Direito Privado 1); Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2024; Data de Registro: 07/08/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. Autor apresentou recidiva de câncer de pulmão em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

2019, com surgimento de linfonodomegalias mediastinais nódulo pulmonar LIE. Tratamento com medicamento "Pembrolizumab". Sentença de parcial procedência, isto para condenar a ré a fornecer o tratamento indicado, conforme prescrição médica, bem como a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Paciente submetido a diversos tratamentos anteriores e que apresentou recidiva. Enfermidade prevista contratualmente. Indicação médica. Negativa indevida. Incidência das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Com a vigência da Lei 14.454/2022 não há mais que se falar que o rol da ANS é taxativo, cabendo a operadora comprovar, para os tratamentos que em princípio nele não estão incluídos, o não preenchimento dos requisitos supracitados. Predominância do direito à vida. Precedentes. Danos morais. Configuração. Sofrimento evidente diante da gravidade do quadro clínico da paciente. Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1054178-67.2023.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024)

Portanto, considerando-se a existência de relatório médico pormenorizado a respeito do caso da parte autora, parecer favorável do NAT-JUS e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a obrigação de fornecimento do fármaco em casos semelhantes ao presente, mostra-se desnecessária a produção probatória.

Ante o exposto, indefiro os pedidos instrutórios e procedo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC).

MÉRITO

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de plano de saúde e de seguro saúde

De início, cabe observar que a atividade realizada pela parte requerida como operadora de saúde adequa-se ao disposto no art. 3.º, *caput*, do CDC; e, de igual forma, a posição da parte autora, como contratante de tal atividade, encontra amparo no art. 2.º, *caput*, do CDC, de modo que a legislação consumerista é aplicável no caso concreto.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

Súmula n.º 608 ("*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*"), corroborado por precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, consolidados na Súmula n.º 100 ("*O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais*").

De rigor, portanto, que seja aplicado o CDC na relação jurídica trazida à análise do juízo.

Pedido de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento e tratamento em assistência suplementar à saúde

Em síntese, a parte autora sustenta a existência de obrigação da parte autora para que proceda ao custeio de medicamento indicado pelo corpo médico que a acompanha.

A esse respeito, cabe consignar, de início, que, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo, consolidado na Súmula n.º 102, cabe ao médico e não ao plano de saúde a determinação do tratamento adequado ao caso, isto é, *"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"*.

Com efeito, se presente cobertura da patologia, incumbe ao prestador de serviços o custeio dos meios necessários à tomada das providências indispensáveis ao seu tratamento, nos termos em que realizada a indicação pelo médico que acompanha o paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

> PLANO DE SAÚDE. Cláusula excludente de cobertura de prótese e órteses. Prescrição cirúrgica de realização de Cranioplastia com prótese customizada, conforme relatório médico juntado aos autos. Artefato indispensável ao próprio ato cirúrgico. Obscuridade dos termos prótese e órtese ao consumidor ferem o princípio da transparência da oferta. <u>Negativa de cobertura não pode prevalecer. Se o contrato cobre a moléstia, deve oferecer os meios curativos necessários a tanto</u>. Abusividade da cláusula excludente. Obrigação de custeio do procedimento e do material. Argumento de que os métodos terapêuticos não estão previstos no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a cobertura. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o paciente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Tratamento indicado por médico especialista. Recente precedente do STJ em sede de embargos de divergência contempla diversas exceções ao entendimento da natureza taxativa do rol. Recente Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que admite cobertura de tratamento não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

previsto no rol da ANS, observadas as diretrizes estabelecidas em seus dispositivos. Caso concreto se encaixa nas normativas que admitem cobertura. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001155-65.2022.8.26.0514; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 01/11/2023; Data de Registro: 01/11/2023)

Nesse contexto, não se desconhecendo o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do n.º EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022, existem, ao menos, duas razões que afastam a sua aplicabilidade no caso concreto: primeiro, o entendimento proveniente da jurisprudência na direção de que, aplicá-la na específica hipótese dos autos, implicaria em "*dizer que em poucos anos dezenas ou centenas de novas técnicas estariam excluídas de cobertura contratual, em manifesto detrimento dos segurados*", dado que "*entre a aceitação de novos procedimentos pela comunidade científica médica e os demorados trâmites administrativos de classificação, não pode o paciente permanecer a descoberto, colocando em risco bens existenciais*" e, assim "*não pode um catálogo de natureza administrativa como o da ANS contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados com base científica*", de modo que "*a pretendida exclusão do custeio desse tratamento somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e a cura proposta, o que não é o caso dos autos, não se tratando, sequer, de tratamento tido por experimental*" (TJSP, AC n.º 1027056-08.2021.8.26.0114, 1.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, julgado em 17.04.2023); e, segundo, a superveniência da Lei n.º 14.454/22, que estabeleceu o denominado rol exemplificativo com condicionantes da ANS, ao dispor que "*em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde*", distinção, que, no mais, tem sido aplicada recorrentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (*cf.*, p. ex., REsp n.º 2.019.618/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022).

No que diz respeito ao fornecimento de medicamentos no âmbito da assistência à saúde suplementar, cabe referir, de início, que, nos termos do entendimento estabelecido pelo Tema n.º 990 do Superior Tribunal de Justiça, adotado, de igual modo, no Tribunal de Justiça de São Paulo (*cf.*, p. ex., TJSP; Agravo de Instrumento 2303785-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023), "*as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA*", requisito, portanto, indispensável à procedência de pedidos de tal teor.

Nesse contexto, tratando-se de cobertura de internação, e relativamente aos medicamentos a serem fornecidos, deve ser observado o disposto no art. 12, II, alíneas *d* ("*cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar*") e *g* ("*cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar*") da Lei n.º 9.656/1998, que os garantem, nos termos da Resolução Normativa ANS n.º 465/2021 − observadas as considerações acima a respeito de seu caráter exemplificativo.

Ademais, na eventual hipótese de tratamento a ser realizado em âmbito domiciliar, deve ser observado o disposto no art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/1998, pelo qual dispensada a cobertura de medicamentos a esse respeito, exceto a relativa a "*tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes*" (art. 12, I, *c*, Lei n.º 9.656/1998) e medicação assistida (*home care*), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ("*é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)*", REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.).

No caso dos autos, o tratamento pleiteado na via jurisdicional pela parte autora satisfaz aos requisitos em epígrafe.

Primeiro, porque há indicação médica, nos termos do relatório médico de fls. 32, no sentido de que se trata de paciente com diagnóstico de "*adenocarcinoma de pulmão*", com estadiamento IIIA, realizando-se, para tanto, a indicação de "*tratamento com quimioterapia neoadjuvante para tratamento de adenocarcinoma de pulmão estadiamento IIIA*", com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

"*protocolo de estudo Keynote 671 que mostrou AUMENTO DA SOBREVIDA LIVRE DE EVENTOS DE 62,4% o grupo que recebeu pembrolizumabe neoadjuvante versus 40.6% no grupo placebo; houve também AUMENTO DA SOBREVIDA GLOBAL DE 80.9% VERSUS 77.6% e RESPOSTA PATOLÓGICA MAIOR EM 30.2% VERSUS 11% no grupo placebo*", tratando-se, portanto, de quimioterapia e de antineoplásico, estando conforme, portanto, o disposto no art. 12, II, alíneas *d* e *g* da Lei n.º 9.656/1998

Nesse contexto, a negativa de cobertura para o tratamento, nos termos da documentação de fl. 170, ocorreu porque "*após análise técnica da equipe de auditoria evidenciamos que a indicação de tratamento com PEMBROLIZUMBE não possui respaldo em bula e reconhecimento nos órgãos reguladores nacionais, configurando em uso Off Label*", afirmando-se, ainda, em mensagem posterior, que se trata de tratamento "*experimental*" (fl. 171).

Ocorre que, nos termos do acima fundamentado, referida negativa mostra-se ilícita, considerando-se que, na forma da mencionada Súmula n.º 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo, incumbe ao médico e não ao plano de saúde a determinação do tratamento adequado ao caso, mencionando-se, em acréscimo, a existência de precedentes da Corte em que negativas da mesma técnica foram reputadas como contrárias à regulamentação aplicável à saúde suplementar − em precedentes nos quais, inclusive, afastados os argumentos de que se consubstancia em tratamento experimental, vez que o fármaco encontra-se regularmente registrado na ANVISA:

> APELAÇÃO − OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS − Plano de assistência à saúde − Autor diagnosticado com câncer de pulmão − Prescrito tratamento de imunoterapia (Prembolizumabe + Carboplatina) − Recusa de cobertura − Procedência − Indenização fixada em R$10.000,00 − Insurgência da operadora − Alegação de que: i) o <u>medicamento foi prescrito em caráter off label, o que não seria permitido; ii) não cabe indenização por dano moral − Descabimento − Devida a cobertura de tratamentos antineoplásicos</u> − Irrelevância da natureza off label do medicamento − Precedentes do STJ − Recusa injustificada para o tratamento que implica dano moral − Sentença mantida − RECURSO IMPROVIDO.
>
> (TJSP; Apelação Cível 1018375-67.2023.8.26.0344; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Ação cominatória. Decisão que deferiu a tutela antecipada para impelir a operadora de saúde ao fornecimento de terapia combinada de quimioterapia e imunoterapia de Carboplatina AUC 5 + Pemetrexede 500 mg/m2 + Pembrolizumabe 200mg IV, além de Pembrolizumabe de manutenção. Recurso da demandada. Medicação em caráter experimental, sem respaldo clínico e reconhecimento dos órgãos responsáveis. Não acolhimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, do art.300, do CPC. Demonstrados o risco de dano, bem como a probabilidade do direito. Compete exclusivamente ao médico a recomendação do tratamento adequado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Inteligência dos enunciados das Súmulas nº 95 e 102 desta Corte. Demonstrados o risco de dano, bem como a probabilidade do direito. Reversibilidade da medida. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2071959-60.2024.8.26.0000; Relator (a): Emerson Sumariva Júnior; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2024; Data de Registro: 02/05/2024)

PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER − Pleito para revogação da liminar concedida para fornecimento da medicação KEYTRUDA − PEMBROLIZUMABE, indicada para neoplasia maligna metastática de pulmão (CPCNP) que acomete a agravada − Descabimento − Medicação prescrita para a doença da recorrida como tratamento adjuvante, que foi aprovado pela ANVISA desde 23 de maio de 2022, indicada para o tratamento de câncer pulmão − Relatório médico encartado aos autos que aponta ser o medicamento prescrito imprescindível ao controle da situação em que se encontra a recorrida − Aprovação do medicamento que já existe há anos, não se tratando de tratamento experimental, mas pertinente e eficaz contra o câncer de pulmão de células não pequenas − Precedentes desta Corte - Decisão mantida. PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Liminar concedida que não se reveste de irreversibilidade - Agravante que, em caso de improcedência da lide, poderá ser futuramente ressarcida pela agravada. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2336236-38.2023.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

De se registrar, ainda, a existência de informações técnicas, provenientes do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT-Jus) favoráveis à técnica referida em casos semelhantes aos dos autos, tal como a NOTA TÉCNICA Nº 78/2023 - NAT-JUS/SP.

Segundo, porque, conforme consulta realizada no sítio < https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> na data em que prolatada esta sentença, o medicamento em questão encontra-se registrado, de modo que não há ofensa ao disposto no Tema n.º 990 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cabe mencionar, em acréscimo, que, conforme documentação oficial de fls. 75/169, qual seja, a bula do medicamento aprovada pela ANVISA, há expressa indicação para o tratamento do câncer de pulmão:

> *Câncer de pulmão de células não pequenas*
> *KEYTRUDA® (pembrolizumabe) é indicado em combinação com quimioterapia a base de platina e pemetrexede para o tratamento de primeira linha em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) não escamoso, metastático e que não possuam mutação EGFR sensibilizante ou translocação ALK.*
> *KEYTRUDA® (pembrolizumabe) é indicado em combinação com carboplatina e paclitaxel ou nab-paclitaxel para tratamento de primeira linha em pacientes com CPCNP escamoso e metastático.*
> *KEYTRUDA®, em monoterapia, é indicado para o tratamento de pacientes com CPCNP não tratado anteriormente, cujos tumores expressam PD-L1 com pontuação de proporção de tumor (PPT) ≥ 1%, conforme determinado por exame validado e que não possuam mutação EGFR sensibilizante ou translocação ALK, e que estejam: o em estágio III, quando os pacientes não são candidatos a ressecção cirúrgica ou quimiorradiação definitiva, ou o metastático*
> *KEYTRUDA®, em monoterapia, é indicado para o tratamento de pacientes com CPCNP em estádio avançado, cujos tumores expressam PD-L1, com PPT ≥1%, conforme determinado por exame validado, e que tenham recebido quimioterapia à base de platina. Pacientes com alterações genômicas de tumor EGFR ou ALK devem ter recebido tratamento prévio para essas alterações antes de serem tratados com KEYTRUDA®*
> *KEYTRUDA® em combinação com quimioterapia a base de platina é indicado para o tratamento neoadjuvante de pacientes com CPCNP ressecável em estádio II, IIIA ou IIIB (T3-4N2), e então continuado como monoterapia para tratamento adjuvante.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

**Esta indicação foi aprovada com base na análise interina do desfecho sobrevida livre de evento de um estudo clínico de Fase 3 (KEYNOTE-671) cujos os desfechos de eficácia primários foram sobrevida livre de evento e sobrevida global. A manutenção da aprovação para esta indicação depende da verificação e descrição do benefício clínico das próximas análises interinas e final do estudo KEYNOTE-671.*
KEYTRUDA® como monoterapia é indicado para o tratamento adjuvante de pacientes com CPCNP em estádio IB (T2a ≥ 4 cm), II ou IIIA, que tenham sido submetidos à ressecção completa e quimioterapia à base de platina

Dessa forma, de rigor que seja garantido à parte o tratamento indicado pela equipe médica que a acompanha, julgando-se procedentes os pedidos.

DISPOSITIVO

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, fazendo-o com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

- condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente na adoção das providências necessárias ao custeio dos meios para que se realize o tratamento prescrito pela médica que acompanha a parte autora, pelo tempo por ela entendido como necessário, inclusive quanto ao fornecimento da medicação, conforme indicação de fls. 32/34.

Tutela provisória

Mantenho a tutela provisória anteriormente deferida.

Sucumbência

Em razão de sua sucumbência, condeno a parte requerida a pagar:

- as custas e as despesas processuais, reembolsando-se eventuais dispêndios antecipados pela parte contrária (art. 82, *caput* e § 2.º, CPC), observados a Lei n.º 11.608/2003, as regulamentações do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à sua atualização monetária, e o art. 1.098, *caput*, das NSCGJ (“*os processos findos não poderão ser arquivados sem que o escrivão judicial certifique nos autos estar integralmente paga a taxa judiciária com a respectiva vinculação da guia, os honorários devidos aos órgãos públicos ou entidades conveniadas, a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.

multa prevista no §2º, do art. 77, do Código de Processo Civil e as contribuições, ou sem que faça extrair certidão em que sejam especificadas essas parcelas para fins de inscrição da dívida ativa”);

- os honorários advocatícios sucumbenciais dos procuradores da parte contrária (art. 85, *caput*, CPC), os quais, considerando-se os critérios do art. 85, § 2.º, I a IV, CPC, fixo em 10 % do valor da causa.

Providências finais

Com o trânsito em julgado, se nada se requerer, arquivem-se os autos.

Registre-se, por fim, que as questões veiculadas às fls. 458/461 serão objeto de tratamento no âmbito da fase de execução do julgado, inclusive na execução provisória já em curso, autuada sob n.º 0038997-09.2024.8.26.0100.

Comuniquem-se, se necessário servindo a cópia desta sentença como ofício e/ou mandado.

Local e data registrados eletronicamente.

P. R. I. C.

São Paulo, 12 de novembro de 2024.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS, liberado nos autos em 12/11/2024 às 16:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1112876-32.2024.8.26.0100 e código vO7Z4YTM.